

05 - 01-Sémiologie gynécologique - Pr. FAKHIR

Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter, dans le cadre de la Séméologie 2 de la 2e analyse des usines médicales, le chapitre de la Séméologie gynécologique. Donc, je suis François Farré-Bauchelard, gynécologue obstétrique.

Les objectifs de ce cours, c'est permettre aux étudiants de savoir interroger ou mener un interrogatoire complet avec une patiente qui se plaint d'un problème gynécologique. Deuxièmement, connaître les principaux motifs de consultation dans une consultation gynécologique et connaître les différentes étapes de l'examen clinique. Donc, nous allons procéder par détailler l'interrogatoire, les éléments qu'il doit contenir, comment les mener et ensuite, comment faire un examen gynécologique.

Comme rappel anatomique, l'appareil génital femelle est constitué d'une partie externe, donc l'appareil génital externe, qui, comme vous le voyez sur ces schémas en haut à gauche, représente donc la vulve avec ses différentes parties, notamment les grandes lèvres, les petites lèvres, les vestibules avec l'orifice uréthrale et l'orifice vaginal, et puis la fourchette vaginale postérieure. Puis, le sein fait partie aussi de l'appareil génital. Et donc, lors de l'examen gynécologique, on devrait examiner obligatoirement le sein.

Le sein est facilement examinable, puisque c'est un organe superficiel, sous-cutané, qu'on peut palper, qu'on peut inspecter et même sur lequel on peut réaliser de l'imager très facilement. Puis, il y a les organes génitaux internes, notamment, comme vous le voyez sur la coupe en bas et à gauche, on voit au centre qu'il y a l'utérus, qui est antéverté et qui repose sur la vessie, et qui communique avec le milieu extérieur par le vagin. Et c'est par là qu'on va pouvoir explorer le col dans sa partie intravaginale, qui se trouve à l'intérieur du vagin.

Et on va voir qu'on peut le voir par l'intermédiaire du spéculum, comme on peut le toucher par le toucher vaginal. On peut aussi explorer l'appareil génital en utilisant le toucher rectal, puisqu'on voit qu'il y a quand même des rapports intimes entre le rectum en arrière et le vagin, et le col en avant. Et donc, on peut utiliser le toucher rectal pour faire le diagnostic de certains problèmes cervicaux, et surtout, l'utiliser comme un moyen de toucher pelvien chez la patiente qui est encore vierge.

Le toucher rectal aussi peut nous mettre en contact directement avec le fil de sable et de glauque, comme vous voyez, un peu en vert, entre le rectum et l'utérus. Bien évidemment, l'appareil génital est aussi constitué des ovaires et des trompes, qu'on voit un petit peu derrière les gros vaisseaux iliaques. Et bien, il y a l'ovaire et la trompe, qui sont plutôt latérales, qu'on peut palper latéralement par rapport à l'utérus.

Sur cette diapo, on peut reconnaître les différentes phases d'un cycle menstruel. De haut en bas, on voit le cycle de développement folliculaire, avec le développement d'un follicule domino, qui

par la suite va donner une ovulation, et par la suite, on va devenir une courbine qui va produire beaucoup de progestérone. En sachant que le follicule, au tout début, il produit beaucoup d'oestrogène, c'est pour ça que sur les courbes au milieu, on voit que dans la partie où la première moitié du cycle, qui est la phase folliculaire, il y a le développement des follicules, on trouve que l'oestrogène augmente de façon importante, jusqu'à un maximum, et elle entraîne avec elle une augmentation de la FSH, qui est moins importante que l'augmentation de la LH.

L'ovulation survient quand il y a une chute brutale de la LH, ce qui entraîne l'expulsion de l'ovulation. Et puis, ceci donne naissance aux courbines qui vont produire du progestérone. On voit sur la courbe que la deuxième phase, qui est la phase luthéale, il y a une sécrétion de progestérone qui augmente de façon importante, alors que l'oestrogène reste à peu près moins important.

Sur ce même schéma, on voit tout en bas, l'évolution de l'onomatopée au cours du cycle mensuel. On sait que l'onomatopée prépare chaque mois à l'accueil pour se féconder, pour l'éventualisation sexuelle, et donc chaque mois, la phase folliculaire, c'est la phase préovulatoire oestrogénique dans laquelle il y a une croissance endométriale, alors que la phase luthéale, c'est la phase progestéronique, c'est une phase sécrétoire dans laquelle les glandes se développent au maximum, elles se créent au maximum, on se prépare à la réfection de l'ovulation. Et quand la grossesse ne survient pas, le corps jaune s'arrête de produire le progestérone, il chute, c'est ce qui va tenir, justement, le déclenchement de la menstruation et donc les règles.

Et donc, vous voyez que tous ces éléments-là, ils sont reliés les uns avec les autres, et que sur le plan sémiologique, les signes que nous allons voir quand il y a un problème d'ovulation, ou bien un problème d'état hormonaux, ça peut être le saignement, comme ça peut être l'absence de saignement, notamment l'absence de menstruation, ou un cycle irrégulier. Et là aussi, quand il y a un dérèglement hormonal, l'ovulation peut ne pas se produire, et là on a des problèmes de fertilité par exemple, et donc il faut explorer tous ces éléments-là. Alors, comment mener un interrogatoire en gynécologie ? L'interrogatoire est donc la première étape d'une consultation en gynécologie, mais en fait, il est la première étape dans toute consultation, on commence toujours par un interrogatoire, le mot interrogatoire ne veut pas dire que c'est un policier, ou que c'est sévère, ou que c'est un ferme, non, c'est juste le recueil d'une information.

Bien évidemment, il faut que le contact avec la patiente soit le plus souple possible, le plus chaleureux possible, surtout en matière de gynécologie, où les femmes doivent parler de leur intimité, doivent parler de leurs problèmes cachés. Donc il faut savoir mener un interrogatoire de façon douce, de façon à mettre la patiente en confiance, lui permettant ainsi de révéler les différents symptômes dont elle souffre. Alors, c'est un temps capital de l'exploration clinique d'un problème gynécologique, toutes les informations médicales recueillies doivent être notées sur le dossier médical, qui va constituer un document à archiver, et donc sera utile pour les consultations suivantes.

Il faut un apprentissage, et donc il faut comment recueillir, par exemple, le médecin de consultation, ensuite recueillir un certain nombre d'informations administratives, rechercher les antécédents, mais surtout ceux qui peuvent être reliés pour obtenir ces consultations, et puis analyse sémiologique du ou des symptômes, alors vous savez la cause des symptômes, c'est un signe fonctionnel que rapporte la patiente, c'est-à-dire qu'elle peut rapporter une douleur, une température élevée, donc une fièvre, elle peut rapporter des diarrhées, elle peut rapporter des saignements. Tout ça, ça s'appelle des symptômes. Alors en gynécologie, quels sont les motifs de consultation en général ? Déjà, en regardant sur l'image en vaïlle à droite, vous voyez qu'il y a une vue par caméra stélioscopique, donc à l'intérieur du ventre du feutre, et on voit la position de l'utérus qui est au centre, donc ce qui est arrondi, bondé, en centre et en haut, et de part et d'autre, on voit les deux trempes, et les deux ovaires qui sont bleues malgré un peu de triangulation.

Alors, on peut se tenir au fond, donc on voit un feu, ce qui correspond au cul de sa glande qui est là, et on voit qu'il y a un rapport intime avec le cul du gestif, et bien évidemment, on voit un rapport avec l'aïs. Donc ceci nous dit que quand on aura des problèmes gynécologiques, donc la symptomatologie peut apparaître au niveau de la région pénévienne, mais aussi elle peut influencer un peu la région abdominale, et la même chose quand il y a des problèmes digestifs, aux dépends du cément, ou de la palisse, ils peuvent donner des douleurs, ou des signes qui peuvent dépasser un peu vers le pénis, et donc on se fait une diagnostic différenciée. Donc, quand une patiente se présente à une constatation gynécologique, c'est soit qu'elle a des anomalies du cycle mensuel, soit des cycles longs, soit des cycles courts, soit absence de règles, soit des règles trop abandonnantes, etc.

Ou bien qu'elle a des hémorragies génitales, si on parle d'hémorragies génitales, c'est en dehors de la période des règles, puis ça peut être des douleurs péniennes, elle peut se plaindre de sécrétions génitales anormales qu'on appelle les leucorrhées, et là, ce sont des sécrétions génitales non sanglantes. Elle peut se plaindre de descente d'organes, et là on est dans le terme de ce qu'on appelle le prolapsus ou les prolapsus génitaux, qui peuvent être associés à des troubles urinaires. Elle peut se plaindre de cinéma amer, et donc on doit faire un examen de taille des seins, comme elle peut se plaindre des troubles de la sexualité ou des troubles de la fertilité.

Après avoir recueilli le motif de consultation, qui est généralement un ou deux choses de ce que nous avons déjà cité, pour le dossier médical, on doit recueillir des informations administratives précises et correctes, telles que le nom et le prénom, parce que c'est important d'avoir le nom réel de la patiente, et de ne pas se tromper en inscrivant le nom de la patiente, parce que son dossier est un dossier quand même collégial, mais aussi c'est une référence archivée pour les autres médecins qui vont voir la même patiente. Donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait des erreurs dedans. On devrait aussi enregistrer l'âge de la patiente, son adresse, son numéro de téléphone personnel, au cas où on voudrait la recontacter par la suite, sa situation familiale, c'est-

à-dire paternité, dérivance, et ça c'est important dans un interrogatoire en gynécologie obstétrique, parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent être liées par des facteurs de risque en rapport avec le statut matrimonial, c'est-à-dire est-ce que c'est une patiente qui est en couple stable, ou bien elle n'est pas stable dans un couple, donc elle peut avoir des rapports avec des partenaires multiples ou autre chose, et ça c'est des facteurs d'infection sexuelle.

La profession aussi peut être importante à connaître, parce qu'il peut y avoir des facteurs de risque liés à la profession, et puis on peut avoir des informations sur le système de sécurité sociale auquel cette patiente est adhérente. Donc après cela, et en fonction du motif de consultation initiale, on devrait réfléchir normalement à l'ensemble des facteurs de risque qui peuvent favoriser tel ou tel diagnostic en lien avec les motifs de consultation. Et donc là on va citer un ensemble d'antécédents, mais quand on fait l'interrogatoire, il se peut qu'on ne cherche pas tous ces antécédents-là, mais on va chercher ceux qui peuvent nous aider dans la recherche de l'étiologie liée aux motifs de consultation.

Alors parmi ces antécédents, on peut demander l'âge de la puberté, on peut demander le cycle menstruel, est-ce qu'il est réglé ou pas. On devrait chercher la date des dernières règles, parce que c'est à partir de là qu'on peut penser à une grossesse et un retard de règles. On peut penser à améliorer, ou bien on pourrait définir des cycles courts.

On devrait demander s'il y a des infections génitales à répétition, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à ça, comme les douleurs péniennes. On devrait avoir une idée sur la contraception reçue par la patiente, parce que certaines dermatologies peuvent être liées au type de contraception, telles que les douleurs péniennes pour les DU, ou les dispositifs intrautérins, ce qu'on appelle couramment les stérilis. Ça peut être donc les troubles de nausées, vomissements, ou bien des tensions mammaires liées à la contraception, etc.

On devrait chercher des antécédents de problèmes de la sexualité, demander après des pathologies gynécologiques, médicales ou chirurgicales, ayant déjà survécu chez ce patient-là. Chercher des antécédents mammaires, antécédents de nodules, de cancers, de chirurgie. Chercher l'âge et la durée de la ménopause, si c'est une patiente ménopausée, parce que là on peut aussi deviner qu'un saignement chez une patiente ménopausée, ça devrait nous faire penser à beaucoup de problèmes, comme le cancer mammaire, par exemple.

On devrait aussi savoir la durée de la ménopause, si elle est ancienne ou de la décision, on devrait penser aussi qu'il peut s'y avoir de l'ostéoporose, et donc on peut faire des investigations dans ce sens. Et puis on devrait aussi demander si cette patiente a effectivement réalisé ces étapes de dépistage que chaque femme en activité génitale doit faire, comme le frottis cervico-utérin ou le frottis cervico-vaginal, et la mammographie. Et donc on devrait déterminer exactement la date de la dernière fois que cette patiente a eu ce dépistage pour que si jamais le dépistage est ancien et la patiente devrait en refaire, qu'on puisse le faire.

Même si ce n'est pas le motif de cette consultation, on va profiter du passage de cette patiente pour lui faire ses examens de dépistage. Toujours dans les antécédents, alors on devrait détailler les antécédents obstétricaux, et ceci surtout si une patiente se présente pour un problème obstétrical, c'est-à-dire lié à une grossesse par membre, comme des fausses couches, comme des avortements, comme une grossesse débutante, tout simplement. Donc on devrait avoir une idée sur les antécédents obstétricaux, notamment la gestité, c'est-à-dire le nombre de procès que la patiente a eu, la parité, qui est le nombre d'accouchements de la deuxième semaine d'améliorée.

Vingt semaines d'améliorée, cela veut dire qu'on compte depuis la date des dernières règles en semaine. On devrait poser la question aussi sur le nombre d'enfants vivants, parce que qui dit parité ne veut pas dire obligatoirement qu'ils sont tous des enfants vivants. On peut avoir des pertes fœtales, liées à plusieurs problèmes.

Les pertes fœtales peuvent récidiver comme elles peuvent ne pas récidiver, mais parfois quand elles récidivent, c'est qu'il y a des problèmes sous-jacents, qu'on devrait chercher pour ça. Alors, avant vingt semaines d'améliorée, une perte fœtale peut être une fausse couche ou un avortement. Et l'avortement peut être spontané, c'est-à-dire qu'il survient brutalement, donc sans intervention, ou bien provoqué, provoqué volontairement, et ce sont les interruptions volontaires de procès qui sont interdites par la loi dans notre pays.

Et les avortements provoqués médicalement ou pour indication médicale, ce sont les interruptions médicales de procès et qui sont autorisées dans notre pays quand il y a un risque sur la vie de la patiente. Et l'exemple le plus connu, c'est des cardiopathies instables, graves, des nécroopathies graves, par exemple. On peut être amené à interrompre la procès parce que la grossesse peut être responsable des mortalités maternelles.

Puis les avortements peuvent être précoces, ou les fausses couches précoces, c'est à faire en 10 semaines, ou tardives, entre 9 et 20 semaines d'amélioration. Donc on appelle les avortements, par exemple, spontanés, tardifs. Après 20 semaines d'améliorée, alors si le suicide n'est plus, on parle de morte totale, ou bien s'il est accouché très tôt, donc avant le terme, on parle d'accouchement prématuré.

Accouchement prématuré, la survie de fœtus dépend de l'âge de cet accouchement. Plus il est accouché très tôt, plus le risque de mortalité est important. Puis on devrait poser la question sur le déroulement des procès et des accouchements antérieurs.

Est-ce que le suivi était normal ? Est-ce qu'il y avait une hypertension artérielle, un diabète gestationnel ou autre ? On devrait savoir, est-ce qu'il est accouché soit par l'embrasse, soit par ses arrières, soit par l'utilisation d'un instrument comme le forceps, c'est là où on est tous. Et puis le terme de l'accouchement, est-ce que cette patiente est accouchée à terme, ou bien prématurément, ou bien elle a eu un dépassement de terme, parce que les prématurités ou le

dépassement de terme peuvent récidiver aussi. Après cela, on recherchera les antécédents généraux, donc antécédents médicaux, personnels, notamment de cardiopathie, de pneumopathie, de prise médicamenteuse, les habitudes toxiques comme tabagisme, alcoolisme et autres, qui peuvent avoir une influence sur les facteurs de risque, de pathologie comme par exemple le tabagisme pour le cancer du sein, puis les antécédents familiaux, donc le cancer comme le cancer du sein, le cancer de l'envers, l'antécédent du diabète, HCA, tuberculose, le coagulopathie, etc.

Après avoir recueilli toutes ces informations concernant les motifs de consultation, les informations administratives et puis les antécédents, on devrait aller pour détailler et analyser les symptômes rapportés par la patiente, c'est-à-dire que la patiente, vu qu'elle a quelque chose, il faut poser maintenant des questions dirigées pour pouvoir ressortir les caractéristiques de ces symptômes-là, lesquelles caractéristiques pourront nous orienter vers tel ou tel diabète. Alors, parmi les principaux symptômes dont se plaint une patiente, c'est les anomalies de cycles menstruels et les hémorragies génitales. Normalement, idéalement, un cycle menstruel est généralement de 28 jours, plus ou moins 7 jours, entre 20 et 30 jours, avec un saignement liquide rouge sombre fluide, qui est incoagulable, et ça peut durer 3 à 6 jours, et l'abondance est variable.

En général, il doit être inférieur à 4 à 6 étapes, et puis souvent abondant les 2 à 3 premiers jours, et après les quantités deviennent plus minimales. Donc ça c'est la normale. Tout ce qui va sortir de cette normalité, notamment la durée en jour, la quantité, la présence de cailloux, d'abondance, de saignements, la durée des démonstrations, etc., tout ça, ça va constituer les différents symptômes gynécologiques que la patiente pourrait rapporter.

Premier symptôme, c'est ce qu'on appelle les saignements anormaux, ou plus précisément les saignements utérins anormaux. C'est tous les saignements qui ne sont pas liés à des règles normales. Les règles normales, c'est ce que nous venons de décrire.

Maintenant, ce qui va être différent de ça, va constituer des saignements importants. Donc on peut avoir une hypoménorrhée ou une hyperménorrhée. Hypoménorrhée, c'est des règles à faire 3 jours.

Hyperménorrhée, c'est des règles supérieures à 8 jours. Puis, on peut parler d'oligoménorrhée, c'est des règles peu abondantes. Polyménorrhée, c'est des règles trop abondantes.

Hyperpolyménorrhée, c'est ce qu'on appelle aussi les ménorrhagies, ce sont des saignements en même temps abondants et en même temps prolongés. Puis, la polachie-ménorrhée, c'est des cycles trop courts. La spanio-ménorrhée, c'est des cycles longs.

Spanio, pour espace. Polachie, c'est quelque chose de rapide. Puis, il y a les métrorragies, c'est tous les saignements anormaux, d'origine, etc., mais sans rapport avec les règles, c'est-à-dire en dehors de la période des règles.

Donc ici, c'est un, on l'appelle un pictogramme, c'est-à-dire des petits carnets avec un tableau sur lequel la patiente peut marquer les jours de saignement, mais aussi les quantités de saignement en augmentant le nombre de carreaux remplis par jour. Donc, sur celui d'en haut, on voit que les règles sont survenues vers le 28e jour du cycle et qu'elles sont peu abondantes et là, elles n'ont, c'est-à-dire, elles n'ont duré que deux jours. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle l'hypoménorrhée, c'est des règles courtes, moins de trois jours, parfois un jour et quelques heures.

Et puis, le deuxième pictogramme, le deuxième graphe, le tableau, je veux dire, numéro 2, donc là, nous avons vu que les règles surviennent de façon régulière, donc entre le 1 et le 28, donc le 28e jour, donc la longueur du cycle est normale, mais le nombre de jours de saignement est trop lent puisque ça arrive jusqu'à dix jours, huit à dix jours. Et là, on est dans l'hyperménorrhée. Ensuite, on voit sur le graphique numéro... le troisième graphique de la diapo et là, c'est écrit donc, troubles de l'abondance des règles.

Un, les premiers, c'était troubles de la durée des règles, d'accord ? C'était les pauvres et les terres. Puis, les troubles de l'abondance des règles. Ensuite, un oligoménorrhée.

Il y a des règles très faibles, très pauvres en quantité et peuvent être réduites à quelques tâches. Et là, on a la patiente remplie uniquement un petit cas, d'accord ? Ils ont duré trois jours, mais très peu abondance. Au contraire, dans le numéro 2, on a la polyménorrhée, c'est-à-dire l'abondance excessive.

On voit qu'on a rempli les trois croix, ça veut dire que la quantité est importante. Puis, il y a la ménorrhagie, c'est en même temps la durée qui est au-delà des trois jours et la quantité qui est importante. Alors, j'ai métrorrhagie.

Les métrorrhagies, regardez, c'est différent de ce qui se passe dans les tableaux en haut. Les tableaux en haut, il y a un resté de la cyclicité, hein. C'est cyclique.

À 28 jours, ça recommence. Mais là, on voit qu'il y a cinq jours de saignement de moyenne abondante et que ça s'arrête. Puis, au huitième jour, ça resseigne.

Puis, au onzième jour, ça resseigne. Puis, au dixième jour, ça resseigne. Au vingt-deuxième, vingt-quatrième, jusqu'à arriver à une nouvelle règle, qui sont aux vingt-huitièmes jours du cycle.

Le cycle commence toujours par le premier jour des règles, hein, qu'on n'est pas oublié. Ça, c'est ce qu'on appelle les métrorrhagies. C'est un saignement qui n'est pas cyclique par rapport aux règles.

Enfin, il y a les ménométrorrhagies. C'est quand on a les deux, en même temps, l'anomalie des règles, qui est trop longue et trop abondante, et en même temps, on a des saignements en

dehors de la période. Ces saignements utérins ont été classifiés récemment sous le nom de l'hémorragie utérine anormale, le saignement utérin anormal.

Et ils ont été répartis en fonction de l'éthiologie en deux signes, qui sont à gauche, les palmes, et à droite, les cônes. Palme, c'est la pente de la mort en anglais. Cône, c'est une pièce de monnaie, qui est sûre en or.

Alors, ces initiaux se rapportent aux différentes étiologies de ces saignements utérins anormaux. Sachez que les saignements utérins anormaux ne contiennent pas les lésions cervicales. Tout ce qui est en rapport avec l'utérin.

Donc, ça peut être un bruit, ça peut être de la déliriose, de l'ihoméame. Tout ça, ce sont des diagnostics. Alors, tout ce qui est palme, ce sont des lésions organiques au niveau de l'utérus, et qui font saigner.

Alors que tout ce qui est cône, c'est des lésions non-structurales, non-organiques, et qui ne sont pas directement liées à l'anatomie de l'utérus. Alors, comme les colulopathies pensaient, les dysfonctions ovariennes, donc, la dysfonction ovarienne, ou la dysfonction non-ovarienne, comme les ovaries oculopédiques. Puis, les anomalies endométriales, de l'endométrium, des problèmes myotrogènes, comme la prise médicamenteuse, et puis, il y a le N pour le non-encouragé.

Donc, c'est une façon d'apprendre rapidement les différences étudiées. Ce n'est pas le but de ce cours, vous ne devez pas apprendre les étiologies, c'est juste pour vous parler de cette classification. Alors, toujours dans les saignements anormaux, l'absence de saignement est aussi un saignement anormal.

Et là, on parle d'aménorrhée, qui est l'absence de règles. Soit c'est une aménorrhée primaire, et la patiente, elle n'a jamais eu de règles depuis la puberté. Et là, quand on va examiner cette patiente, on peut retrouver ou non les signes de puberté, notamment la croissance des seins, la croissance de la pilosité et la taille, etc.

Puis, il y a l'aménorrhée secondaire, quand la patiente a eu déjà une période plus ou moins longue de règles normales, mais qui actuellement ne présente plus de cycles. Alors, autre symptôme très important en médecine écologique, c'est la douleur pelvienne. La douleur pelvienne est un signe très fréquent retrouvé dans les consultations d'une écologie.

Et quand la patiente se plaint de douleur pelvienne, il faut ressortir tous les caractéristiques de cette douleur afin de pouvoir la classer et de pouvoir s'orienter au niveau diagnostique. Comme on l'a vu tout à l'heure, la préjugée est en rapport avec la vessie, le rectum, il y a la paille à côté, il y a les tubules aussi à côté. Donc, il faut vraiment détailler la sémiologie afin de s'orienter vers tel diagnostic.

Donc, on devrait déterminer le niveau de douleur, est-ce que c'est brutal, est-ce que c'est insidieux, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants particuliers de la douleur, comme par exemple les règles, les douleurs qui se voient uniquement au niveau des règles. Et puis, le type de douleur et son intensité, est-ce que c'est des craintes, est-ce que c'est des torsos ? Et là, on rappelle qu'il y a la pathologie des torsos d'annexe, qui est une grosse chirurgie qui peut se manifester par une douleur aiguë. Il y a la grossesse extraterrestre aussi, qui peut se manifester par une douleur aiguë, qui peut se manifester par une douleur aiguë.

Il faut ressortir aussi le rythme de ces douleurs, est-ce que c'est aiguë une fois que c'est terminé, ou bien c'est périodique, ou bien c'est continu, ou bien c'est aiguë, ou bien c'est chronique. Pour la douleur chronique, il faut ressortir est-ce qu'elle est non cyclique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à l'événement donné, ou bien est-ce qu'elle est cyclique, et généralement les règles sont cycliques en relation avec la période de menstruation, comme par exemple la douleur au moment des règles en relation avec la crise mémorée, les douleurs juste avant les règles, donc ça consiste à ce qu'on appelle le syndrome pré-menstruel, puis les douleurs latéralisées dans le pelvis qui surviennent au milieu du cycle aiguë. Et là, généralement, c'est le syndrome inter-menstruel, etc.

Donc, quand on caractérise la douleur en ligne chronique, cyclique, non cyclique, ou bien continue, eh bien, on peut s'orienter vers un profondeur médiatique. Ensuite, il y a la leucorrhée, et là vous allez avoir un chapitre à part sur la leucorrhée, là, c'est un écoulement ou des sécrétions génitales, cervico-vaginaux vulvaires, qui ne sont pas sanglantes, c'est-à-dire en dehors des seignements. Donc, comme on voit sur l'image, on voit des sécrétions un peu blanchardes qui sortent à partir de la douleur.

D'habitude, et de façon physiologique, on peut avoir des sécrétions génitales, plutôt génitales, mais pour dire qu'elles sont physiologiques, il faut que ce soit clair, qu'elles soient peu abondantes, qu'elles soient pas forcément péri-ovulatoires vers le milieu du cycle, elles deviennent un peu plus abondantes. Elles sont indolentes et n'ont pas de signes de fonctionnement d'irritation, c'est-à-dire que le fait d'avoir des sécrétions là ne mérite pas l'arrivée d'une verte qui devient soit pré-rigineuse, soit elle brûle complètement, soit elle donne un inconfort particulier, ce n'est pas le signe d'irritation. Donc, quand on n'a pas tout ça, ça veut dire que ces sécrétions sont tout à fait physiologiques et elles concernent justement le niveau de l'air cervical normal qui d'habitude est plus ou moins emparé de l'eau.

Alors, il faut déterminer la date et le mode de début de ces infections, le caractère d'écoulement, donc surtout sa couleur, son odeur et le fait de présence de pré-riges ou pas, s'il y a une périodicité, mais là surtout, est-ce qu'il y a des récives, est-ce que la patiente guérit un peu pré-très bien si ça revient, les circonstances de ces revenus, est-ce qu'il y a une maladie générale à soucier la patiente, est-ce qu'elle est sous psychothérapie, est-ce qu'elle est diabétique, est-ce qu'il y a une grossesse, est-ce qu'il y a un post-partum ou un post-abortum qui constitue des

facteurs de risque de l'infection immunitaire. La patiente qui a couché à domicile par exemple peut très facilement être infectée et faire ce qu'on appelle une endométrite et avoir des sécrétions fétides qui sont mauvaises et par la suite faire de la pierre pour forcer la pénétration. Donc, il faut déterminer les circonstances d'apparition et puis aussi, il faut demander est-ce que le mari présente une symptomatologie urinaire ou des sécrétions urétrales.

Alors là aussi, parce que les infections génitales chez la femme en période d'activité génitale peuvent être transmises par le conjoint et quand on traite une patiente qui a une infection génitale et qui est mariée il est important de retraiter le mari aussi parce que sinon, elle va résiduer puisque le mari est toujours infecté. Les autres symptômes qui peuvent justement se présenter à la consultation gynécologique c'est les troubles de la sexualité. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle une dyspareunie, qui sont des douleurs au moment des réponses sexuelles rapportées par la patiente.

On peut avoir un vaginisme, c'est l'impossibilité de la pénétration et généralement, c'est des jeunes femmes qui viennent de se marier et qui veulent avoir leur premier rapport et qu'elles n'arrivent pas à accepter la pénétration. Les troubles de la libido, c'est la frigidité, la gâsmie et là, on peut avoir ça dans les périodes de postpartum, surtout chez les patientes qui sont en micro-progestation par exemple. Les patientes qui sont sous traitement neuroleptique ou antidépresseurs ou autres, peuvent aussi avoir des troubles de la libido.

Les troubles urinaires aussi, pourront être rapportés aux gynécologues comme les incontrôlables urinaires, les brûlures mictionnaires et les tuites urinaires. Les signes mammaires peuvent aussi être rapportés. On parle de mastodonie, c'est une douleur mammaire, c'est les bilatérales et unilatérales dans le sein, sur quel cadran et puis, quand on fait la palpation, on peut retrouver des nodules ou des humains.

Mais surtout que la patiente rapporte qu'elle a elle-même senti la présence d'une douleur dans son sein, on parle d'une auto-palpation, c'est-à-dire que la patiente se passe elle-même le sein et trouve une induration elle-même pour constater qu'elle a un nodule par exemple, ou un nodule. D'autres symptômes, c'est les écoulements mammaires, donc ça peut être la galactorée, quand cet écoulement est lactéon, quand il y en a et généralement il est bilatéral et en rapport avec les expressions normales de prolactine. On peut avoir une galactoragie, c'est quand il y a un écoulement sanglant et quand ça a des moments sanglants, c'est plus inquiétant, surtout si c'est d'un seul côté, unilatéral, mais en plus, il est unipore, c'est-à-dire qu'il sort d'un seul pore du mamman, puisque les canaux galactopores, elles s'abouchent au niveau du mamman, au niveau du galactopore, d'accord, ce qui permet au nez d'être sécrété.

Donc on cherche si cette sécrétion est unipore ou multipore, si elle est symétrique ou asymétrique, et puis s'il y a des largeurs, tout à l'heure. Puis, il y a les troubles de la fin de comitè, donc les patients peuvent consulter pour une infertilité primaire, c'est-à-dire que le couple n'a jamais conçu, que la patiente n'a jamais eu de grossesse, ou infertilité secondaire, quand la

patiente a déjà eu une grossesse, soit terminée par un accouchement de l'enfant de l'uniforme, soit par une perte fœtale, mais qu'actuellement, et depuis plusieurs... une année minimum, elle n'a pas pu avoir de grossesse ou pas d'infertilité secondaire. Donc, au terme de tout cet interrogatoire, le médecin devrait pouvoir faire une petite conclusion dans sa tête, qui l'oriente vers où est le problème.

En fonction des motifs de consultation, en ayant posé des questions sur les infirmiers, et puis en détaillant un peu la symptomatologie des acteurs. Donc, déjà à ce niveau-là, il peut avoir une idée sur ce qu'il va chercher à l'examen clinique, que nous allons voir tout de suite. L'examen clinique en gynécologie, en fait, c'est un examen qui a des particularités, puisque c'est un examen entre la femme, donc il doit se faire en intimité absolue, il doit y avoir une conscience de sa femme et de son bébé, et surtout, il faut parler et expliquer tous les gestes qui vont être faits, afin de garantir la confiance et le calme de la patiente.

Alors, quand on veut faire un examen gynécologique, on devrait commencer par l'examen de l'oreille, l'examen de l'abdomen, l'examen des seins, puis examiner les poignées et les prénoms. Alors, l'examen général, c'est comme pour toutes les consultations, ça donne toujours une idée sur l'état hémodynamique de la patiente, ça donne aussi sur les facteurs de risque qui peuvent être associés, et donc, généralement, une patiente déshabillée, dans une salle qui est chauffée, on peut faire notre examen général. Déjà, on peut voir le morphotype, surtout par rapport à l'âge, et là, c'est quand on a des problèmes d'améliorer, par exemple, afin d'examiner les signes de puberté si ils sont présents ou pas.

Donc, la croissance des seins, la présence de pubertés, pubiennes ou axillaires. Puis, on devrait évaluer l'indice de masse corporelle, pour voir si on est dans un l'indice du normal ou à l'indice d'obésité, puisque, en gynécologie, l'obésité est aussi, peut-être, un facteur de risque, ou un facteur qui est dans le symptôme des ovaires polykystiques, qui entraîne des spanioménorrhées, de l'infertilité, du retard de règles. Et l'indice de masse corporelle, on le mesure en mettant le poids en kilos sur la taille au mètre, au carré, et il devrait être, donc, inférieur à 30, pour ne pas retomber dans l'obésité.

On devrait chercher les signes hyperandrogéniques, comme l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence de poils, de façon anormale, chez une femme, au niveau des zones androgéniques. Les zones androgéniques, c'est la bionique, c'est le dos, c'est le visage, et l'effet interne des filles.

Donc, c'est des zones où il ne devrait pas y avoir de plus en plus. Ici, il y en a, ça veut dire qu'il y a un hirsutisme qui est peut-être un hyper androgénique. L'acéborée, comme l'a dit, on peut retrouver une alopie ici, donc l'absence des cheveux ou la chute de cheveux important.

La rossité de la voix, pardon. Tout ça, ça veut dire qu'il y a une hyperandrogénique. Et là, on le retrouve, ce syndrome, on le retrouve dans les zones vulnérables, on le retrouve dans les

infertilités aussi.

Puis, on devrait examiner la thyroïde, le rachis, pendant la température, l'intensité artérielle, les corps, les condensifs. Alors, on cherche aussi l'anémie si la patiente se plaint des saignements anormaux. Alors, pour la suite de l'examen, donc, c'est l'examen de la semaine première.

Ok. Notamment, on fait une inspection, s'il y a une brulure abdominale, une cicatrice ou une herie. Une palpation qui doit commencer par les parties non douloureuses, pour aller vers les parties des enfants.

Chercher le siège et les caractéristiques du masque qui peut être soit abdominal, soit soit pelvien, soit abdominopelvien. Est-ce qu'il y a une contracture ou une défense abdominale ? C'est dans les douleurs aiguës et quand il y a une défense, c'est ce qu'on appelle un abdomen chirurgical. Donc, la patiente a un problème, soit un saignement abdominal, soit une infection, à travers le domicile ou chirurgie.

On peut chercher la rotation des tailles de foie, de reins, de rad, puis la liberté sur la sixième lumière, comme d'habitude, et puis la percussion peut nous mettre en évidence des masses abdominales ou abdominopelviennes. Donc, l'examen doit être fait de façon systématique, parce que parfois, des douleurs peuvent avoir une autre origine que l'appareil génital. L'examen des seins est un temps important de la consultation de gynécologie.

Il devrait être fait systématiquement. Chaque patiente qui vient à la consultation gynéco, même si elle ne demande pas ou elle n'a pas d'honnéances en rapport avec les seins, devrait bénéficier de l'examen systématique des seins afin de déviser ou de découvrir précocement le niveau de seins qui peuvent être un cancer de seins. Ici, on le découvre très précocement.

On améliore la survie de la patiente. De préférence, l'examen des seins devrait se faire vers la fin de règle, toujours de façon bilatérale et comparative, c'est pour ça qu'il faut déshabiller la patiente, son torse et regarder la symétrie des points. Faire une palpation méthodique des deux seins, examiner les incongruïtés et puis faire une synthèse.

Le schéma en bas, on voit qu'on devrait inspecter les seins de façon dynamique en faisant bouger les bras, le ventre du corps sur la taille en haut ou même en faisant pencher la patiente vers l'avant. Ceci permet de faire bouger le muscle pectoral et ainsi mettre en évidence la présence de certaines blocures, de certaines tractions, d'une anomalie de la forme du sein qui devrait attirer notre attention. Donc, l'inspection, on compare entre les deux et il va nous permettre de chercher des anomalies comme les anomalies du galbe, du sein comme on voit sur l'image, vous voyez qu'à côté de l'arrière, on a quelque chose qui attire, qui procède et là, il risque d'y avoir un petit morceau de sang qui tire sur la peau.

Les anomalies de surface comme la présence de rimes d'ongeurs localisées ou d'hypus ou de peau d'orange comme ici. Donc, la deuxième image nous montre les régulations de surface sur

la peau. Puis, l'image en bas, on voit qu'il y a une asymétrie des deux seins, c'est la même chose sur la deuxième image.

L'un des seins est rétracté vers le haut, donc en l'occurrence dans la dernière image, le sein gauche, il est rétracté mais il est plus gros, plus gonflé et on voit qu'il est un peu rouge et qu'il y a de la peau d'orange. Donc, cet aspect de la peau qui est un peu pleine de trous comme la peau d'une orange tout simplement, ça signifie qu'il y a de l'inflammation au niveau de ce sein-là, c'est un cancer, c'est une forme assez avancée puisque ça fait 7-8 ans. Et puis, on peut chercher des anomalies en bois, chercher des anomalies humainement et peut-être déformer, peut-être dévier vers un côté, comme il peut être le siège de comme ici, une exsération ou bien de croûte qui peut être ce qu'on appelle la maladie de panique.

Voilà, on compare toujours les deux seins avec un trou, un tronc nu et donc physiologiquement, on peut avoir petit à petit des tris entre le sein droit et le sein gauche en faisant souvent le sein droit le plus gros, mais c'est ce qu'on voit sur l'image en haut et l'image en bas et à gauche. Sur l'image en bas et à droite, on voit nettement la différence entre les deux seins avec la présence d'une énorme goussure sur le sein droit qui nous oriente vers un module de pèsus. Puis, il y a la palpation, la palpation des seins qui se fait normalement avec les mains à plat et on palpe avec la raison de la pointe de la main au niveau des doigts et ça nous permet de ressentir l'existence d'un nouveau état.

Donc, la passion d'abord reste assise, on palpe le cadran supérieur avec la main à plat, les creux axiaux qui se placent derrière la présence des creux suscréolaires. Puis, on allonge la passion dans les creux dorsales et on continue la palpation des cadrans inférieurs parce que le sein va s'étaler vers le haut et on peut palper les cadrans inférieurs. Alors, sur cette palpation, au moment de cette palpation, il faut ressentir les caractéristiques d'un module éventuellement ressenti.

Un module, c'est comme une boule qu'on retrouve dans le sein. Il peut être petit, il peut être grand, il peut être infrasensimétrique, etc. Et donc, on doit préciser sa taille, on doit préciser son ciel, sa mobilité, sa sensibilité, ce que vous n'avez pas, sa régularité, est-ce qu'elle est régulière ou pas, est-ce qu'elle est bien limitée ou bien délimitée, on ne sait plus, et puis sa consistance.

Et puis sa consistance, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est molle, est-ce qu'elle est ferme, etc. Donc, et à la fin de l'examen, on va chercher un écoulement momentané, donc on précise là le type de sanglants, ce qu'il est l'accession, ce qu'il est l'uniforme, le support, ce qui est symétrique ou pas symétrique. Et puis on cherche les agonopathies actuelles, comme on l'avait dit, et tous clairs.

Et même les méta, à distance, si jamais la personne se craint d'une douleur ailleurs, qu'en parlant d'une douleur au niveau du bâton, du racisme, que le médecin lui conserve du sein, ce sont les douleurs essentiellement plus fréquemment vertes. Donc, ici, on voit les étapes de

développement du sein, donc les mains à plat, on peut palper avec deux mains, mais de préférence on palpe avec une seule main, la main droite, le sein gauche de la patiente, la main gauche, le sein droit de la patiente, puis le creux axillaire, puis les sous-maissures. Alors, toujours dans la palpation des seins, la palpation peut déjà être orientée vers des critères de bénignité et des critères de malignité par rapport à la palpation du nez.

Critères de bénignité, c'est qu'on trouve que c'est un exercice créant, ce n'est pas lisse, qui régule, qui délimite, qui mobilise par rapport à tous les plans, c'est-à-dire, on peut le glisser sous la peau, il bouge, on peut le limiter par rapport au plan musculaire profond, il bouge aussi. Et puis, les tissus à côté sont enfoulés, mais ils ne sont pas envahis. Les critères de malignité, par contre, c'est un endroit qui est dur, qui est pierreux, malin, associé à une rétraction qui permet, autour des cadrans inférieurs, ou une rétraction de la plaque aérologique angulaire, qui nous trouve que le malin a changé de position, il est tiré d'un côté et d'un autre, et la présence d'un écoulement unipore, et surtout sanglant.

Dans les formes localement avancées d'un cancer du sein, on peut trouver des signes plus importants, notamment une adhérence à la peau, adhérence par rapport au plan musculaire profond, c'est-à-dire qu'on parle de la mobilisation de l'épaisseur, des signes inflammatoires, et là, on peut trouver des plaques aérologiques et de l'oxygène qui donne l'aspect de la tolérance. Et puis, la taille du malin reste un élément positif très important dans ce milieu, c'est exactement la taille. Alors là, on a fini l'examen abdominal, on a fini l'examen du sein, maintenant on va voir l'examen du périmètre.

Donc, comme j'ai dit, c'est un peu sensible et il faut respecter l'intimité de la patiente. La patiente est mise en position gynécologique, comme vous voyez sur le schéma à droite et en bas, avec le gynécologue assis sur un tableau avec une bonne lumière. On doit utiliser ce qu'on appelle une table gynécologique adaptée, comme ce qu'on voyait sur le mat, mais il y en a d'autres qui sont plus sophistiquées et écrites.

Et puis, on peut examiner au repos, comme à l'effort, surtout quand il s'agit de problèmes de descente des seins et, comme d'habitude, on fait une inspection. Pour l'inspection, comme on voit à l'avant et à droite, on voit que l'aspect est normal, donc on doit vérifier la pélosité, la pigmentation des tissus, donc entre l'épaisse pierre et les os verts, la présence de cicatrices, il faudrait chercher les zones de changement comme déjà, on peut trouver des oedèmes verts, comme on peut trouver carrément des tumeurs. Donc, de gauche à droite et l'image en bas, celle qui est à gauche, l'écran gauche, on voit qu'il y a un oedème de la buse associé à des sécrétions lécheuses blanches.

Alors là, c'est une infection, c'est une lésion qui donne justement cet aspect d'oedème vert. Après, la seconde image, on voit qu'il y a une zone un peu arrondie d'un châtre qui est irrégulière et d'ailleurs en relève au niveau de l'extrémité postérieure de la grande mer. Et là, c'est une zone qui devrait attirer notre attention et pourrait nécessiter une buse.

Troisième image, on voit des zones pigmentées, un peu brunâtes par rapport au reste de la peau, qui sont un peu disséminées des deux côtés de la visite et même en effectif. Et on devrait des zones comme ça, on devrait des buses parce que ça peut être des zones très cancéreuses, carrément des zones cancéreuses. Et puis, à droite, on voit qu'il y a une tumeur bourgeonnante sur la région du Quy-Torif, en Grèce, c'est le nom du pays.

Et puis, on lève les cendres pour les autres qui ont malheureusement un cancer de la peau. Après l'inspection, ce qui participe à l'examen général physique, c'est d'utiliser un instrument qui s'appelle le spéculum pour faire l'examen et visualiser directement le col. Par la suite, on devrait faire un toucher vaginal et combiné à la profession abdominale.

Éventuellement, on toucherait facilement. Alors, le spéculum, c'est quoi ? C'est un instrument métallique stérilisable ou bien on peut trouver des spéculums en plastique à utiliser. Et le principe, comme vous voyez dans l'image en haut, c'est que c'est un instrument qui a deux balles qui s'ouvrent et qui se ferment à partir d'un système de pivot qui se trouve en bas.

Il suffit qu'on ferme les deux ailes qui se trouvent en bas pour que les balles s'ouvrent et qu'il soit possible de retrouver l'intérieur du vagin. Puis, le spéculum, on devrait choisir la taille en fonction de l'âge mais aussi en fonction de la taille du vagin. Et pour y part, en passant au miniposé, on devrait choisir un petit spéculum ou un spéculum moyen alors que les femmes qui sont grandes, ici non encore miniposées, on peut avoir recours à des spéculums très larges afin de pouvoir voir à travers les valves l'aspect du colique.

Donc, on peut utiliser un lubrifiant pour les stabiliser, ce genre de spéculum mais le lubrifiant ne devrait pas être utilisé quand on veut faire un professionnel pour faire un prélèvement basculologique et vaginal. Sur cette plaque, on a les différentes étapes de l'examen au spéculum et qui devraient être particulièrement euh euh devraient être apprises par cœur par l'éducateur médecin afin de respecter les conditions optimales de d'un côté le confort de la patiente et de son activité et d'un autre côté la technicité, l'hygiène et l'efficacité du geste. Donc, je vous laisse le temps ou plutôt je vous laisse la liberté de lire ce document là à tête reposée aucun détail de ces différentes étapes mais à euh à à laisser au hasard.

Alors ici, pour poser un spéculum, donc il faut d'abord par le pouce et l'index écarter les lèvres par la main rouge puis présenter le présenter par la main droite le spéculum fermé alors on l'introduit fermé c'est très important on ouvre à l'intérieur pour voir et puis on le referme pour le sortir on peut pas le sortir ouvert donc présenter par la main droite le spéculum fermé puis appuyer sur la penchette et enfoncer en faisant à peu près 45 degrés en arrière et en bas parce que c'est la direction du vagin, le vagin est dirigé vers le vague en arrière quand la patiente ils ont des plus torsades. Puis on va ouvrir progressivement en rapprochant les deux ailes donc du spéculum afin de rechercher le col pour l'accoucher entre les deux lames de l'appareil. Il y a deux types donc de spéculum que vous allez voir sur la diapo comme on a vu sur la diapo donc on peut ouvrir en poussant les deux ailes comme on peut ouvrir en tournant une vie.

Donc voici comment on met en place un spéculum on écarte les petites lèvres soit de cette manière soit à partir du haut et on utilise les deux ailes en même temps et donc on introduit le spéculum du début puis on les dirige vers le bas et l'arrière. Et à travers ce spéculum on peut voir ça donc ça c'est les parois vaginales et le col qui est là et on peut même voir cette zone de vision entre l'épithélium spore et l'épithélium cervical. On peut la voir dans le lit parfois si elle est exposée sinon elle est interdite.

Alors en même temps quand on fait cet examen on inspecte et on regarde ce qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a des pertes ? Est-ce qu'il y a des dépressions ? Est-ce qu'il y a du sang ? Est-ce qu'il y a une tumeur ? Et en sortant on vérifie les parois vaginales, surtout pour les patients spéciales parce qu'il peut y avoir des tumeurs vaginales. Et là sur l'image en bas et à gauche, on utilise une brosse pour brosser l'endocolle et l'exocolle afin de prélever les cellules pour l'étude cytologique du frottis cervical vaginal.

Nous allons le voir dans le cours des investigations. A droite, là aussi ça c'est Tequilum en place. Vous voyez les parois vaginales de part et d'autre et ça c'est une spatule d'ailleurs qui permet aussi de prélever des prélèvements cytologiques du col.

Voilà. Donc encore Tequilum, regardez comment on le met en place mais surtout n'oubliez pas la direction en arrière. Puis on l'ouvre et vous voyez en haut et à droite les deux valves se mettent de part et d'autre sur l'endocolle du terrain et permettent de le voir directement.

Donc là il faut remarquer que l'orifice de l'orifice cervical chez les patients familialisés c'est généralement rond et pas si fort. Alors qu'il est plus ou moins gros et déchiré chez l'administrant. Et comme on l'a vu sur l'image devant, on peut voir un peu l'ajustement si elle est extérieure.

Au cours de l'examen aussi, on peut faire un prélèvement pour l'étude de la glaire cervicale et là on verra son abondance, est-ce que la glaire transparente est-ce qu'au contraire elle est trouble ou est-ce qu'il y a du puits dedans, ce qui signifie qu'il y aurait l'infection. Est-ce qu'il est filant, est-ce qu'il est écarté sous son ombre entre le mort d'une patiente en guêpe. Puis on peut mesurer le pH de la glaire qui est de 7 généralement.

Et on peut même voir au microscope qu'elle est incellulaire mais qu'elle cristallise en plus de cellulaire à la fin, ou plutôt à la dissication. Si vous la mettez sur un verre et on la laisse à l'air libre, elle va dissiquer lentement, elle est constituée ou plutôt cristallise. Donc à droite et en bas, on voit l'image d'un col à travers un spéculum.

Vous voyez, il y a comme une goutte qui arrive à partir de l'orifice externe. C'est ça la glaire et on voit qu'elle est translucide et qu'elle n'est pas insécrite. Donc elle est physiologique.

Voici les aspects de col qu'on peut voir. En haut et à gauche, il y a un col normal ce qu'on a vu avec une glaire normale au monde d'ovulation. Puis à droite, regardez, il y a une différence.

C'est un col qui est rouge mais en plus il y a des sécrétions blanchâtres ce qui n'est pas physiologique parce que les physiologiques sont translucides. D'accord ? En bas et à gauche, donc plutôt en bas et à droite on voit un col mais qui est siège d'une formation centrale. Vous voyez qu'il est ronde, qu'il est rose, qu'il est homogène.

D'accord ? Et là ce sont les polypes accouchées par le col. Sinon, pour les deux dernières images, c'est des photos de concerts de col et l'objectif de votre apprentissage c'est aussi d'apprendre à faire des examens le plus fréquemment possible aux patients pour justement ne pas arriver au stade de ces concerts invasifs qui sont enchauffeurs. Alors, au cours de l'examen gynécologique on peut aussi utiliser ou faire une hystérométrie mais il faut savoir que ces indications sont limitées.

On l'a fait quand on veut mettre un déluges ou un stérilet et on devrait mesurer la longueur de l'utérus. C'est une tige qu'on va introduire par le col doucement suivant la courbe du canal cervical et de l'endomètre et aller jusqu'au fond utérin. Dès qu'on sent qu'il y a une petite résistance c'est qu'on est au fond et on regarde les graduations pour mesurer la taille de l'utérus.

Et donc le fait de mesurer cette longueur va être utile quand on veut mettre le stérilet pour ne pas le dépasser et donc créer une rupture utérine ou au contraire mettre le stérilet trop bas parce qu'on n'a pas respecté la distance jusqu'au fond utérin afin de pouvoir le mettre correctement. Donc après l'examen au spéculum vient l'étape du toucher vaginal Alors généralement en gynécologie on ne fait pas le toucher vaginal tout seul mais on le fait de façon combinée avec le papier abdominal comme vous voyez sur les images Alors normalement un utérus normal ne serait pas du tout palpable parce qu'il est complètement rétro-sensible comme vous voyez sur ces trois images. L'utérus il est rétro-sensible donc théoriquement on arrive à peine à le sentir Alors dès qu'il y a une augmentation de la taille de l'utérus, soit parce que il y a une grossesse soit parce qu'il y a une tumeur, il y a un fibron ou autre chose, alors dès que l'utérus est augmenté de taille on va le sentir un petit peu au-delà de la symphise ou au-delà du pubis.

Quand on fait le toucher comme vous voyez sur l'image on pousse l'utérus par les deux doigts vers le haut et là on a senti le col déjà et on peut sentir sa mobilité sa consistance, ce qu'il est dur, ce qu'il n'est pas dur, ce qu'il est régulier ou pas mais on l'a déjà vu pour la régularité, on l'a déjà vu au spéculat et donc avec nos doigts on peut pousser un peu l'utérus à travers le col et palper vers le haut et on peut entre nos deux mains estimer ou on peut imaginer la hauteur de cet utérus, d'accord ? Si on veut palper les annexes, il faut se déplacer avec les doigts de façon latérale au niveau du sac vaginaux et à travers ça on peut palper des masses latérales utérines, c'est-à-dire une masse qui est au dépôt de l'annexe une masse ovarienne une masse tubaire, d'accord ? ou carrément on peut palper le cul de sac du blac qui est juste derrière le cul du sac vaginaire donc déjà à l'introduction on devrait faire attention pour ne pas être traumatique alors quand vous voyez sur la photo ou l'image à gauche d'accord ? donc on voit qu'il y a le urinaire qui est en face et pour commencer on va le toucher de façon brutale on va faire mal à l'aumée et donc

on n'aura rien gagné. Donc on y va doucement, donc on appuie sur la pochette toujours, puis on se dirige en bas et en devant et en fait on se dirige en bas et en arrière d'accord ? pour suivre un peu la courbure du vagin comme vous voyez sur le schéma à droite et en bas on nous montre un peu les longueurs justement d'un doigt par rapport à la longueur du vagin. Le doigt est plus long que le vagin donc il ne faut pas trop forcer dans les mouvements au toucher vaginal alors le toucher vaginal comme tout exomagnique il a des limites c'est à dire on peut ne pas sentir euh l'utérus correctement quand on a une patiente très obèse qui a la paroi minimale épaisse ou une patiente qui a un atrophé vaginal et donc on ne peut pas introduire les deux doigts donc on introduit un seul doigt la patiente vierge on ne va absolument pas faire le toucher vaginal ni le speculaire et puis les médecins droitiers donc vont pouvoir explorer mieux le côté droit du vagin que les personnes que les gauchers et vice-versa donc à côté du toucher vaginal, il y a le toucher rectal qui n'est pas systématique en lignes gynécologiques mais qui peut être utile de le combiner avec le toucher vaginal dans certaines situations comme prolapsus ou au moment de triose parce que en faisant en même temps un toucher vaginal et un toucher rectal, on peut palper ce qu'on appelle la cloison recto-vaginale comme vous voyez sur le schéma à droite et en bas parce que c'est là où certains nodules de l'endométrisque peuvent se localiser alors il va rendre service aussi quand l'exemple vaginal est peu performant une patiente vierge ou une soeur très âgée atrophique et on suspecte quelque chose en latéral utérin ou bien un col qui est déjà dégustiqué être carcinal donc on devrait palper les paramètres et c'est au toucher rectal qu'on peut faire voilà donc jusque là on a fini notre examen gynécologique donc on a fait notre interrogatoire on a fait notre rapport dans lequel on a vu les motifs de consultation on a cherché les impacteurs de risque on a détaillé les symptômes puis on est passé par un examen clinique complet donc on a fait un examen général comme il faut on a examiné les seins on a examiné l'abdomen le périnée et puis enfin le périlis en utilisant le spéculum et le toucher vaginal donc voilà, on a terminé ce cours et voici quelques références pour un peu étudier la sémiologie locale quelques-uns existent au niveau de la bibliothèque de Métis de Marrakech donc je vous invite à aller voir et puis je vous demande rendez-vous pour la deuxième partie notamment les investigations de la pérille génitale donc jusque là, on peut déjà avoir une idée sur les diagnostics ou les diagnostics à évoquer, mais pour les confirmer on a besoin d'investigation et donc c'est ce qu'on va le voir sur le prochain cours je vous remercie